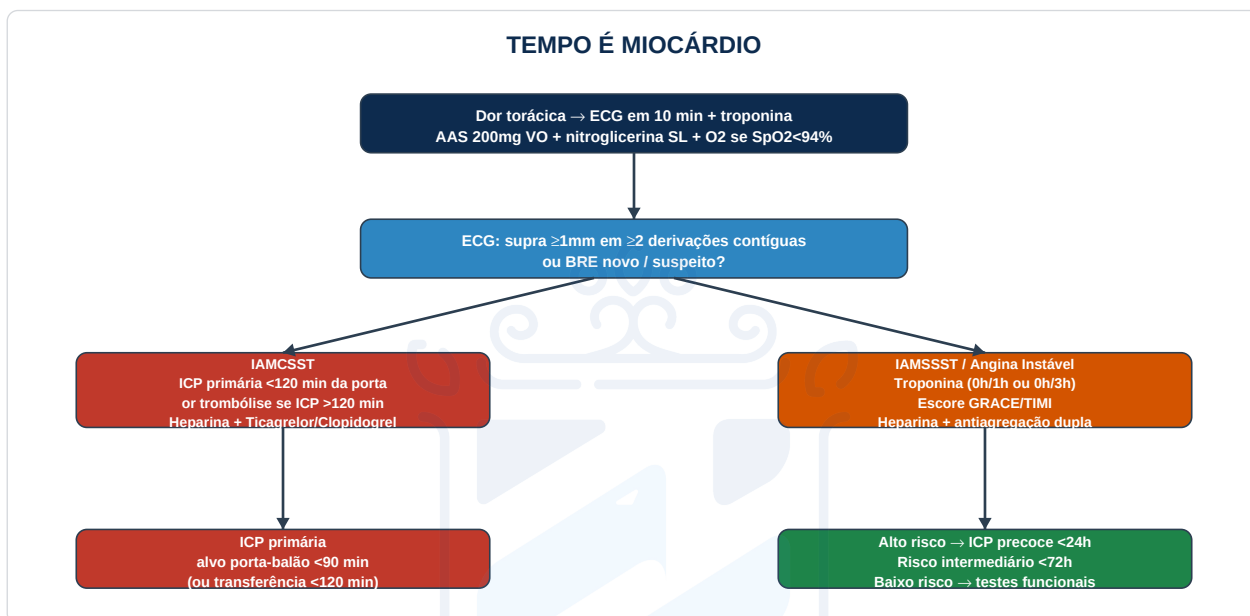


SCA — IAMCSST / IAMSSST / ANGINA

FLUXO DE ATENDIMENTO — SCA



CLASSIFICAÇÃO DAS SCAs

Diagnóstico	ECG	Troponina	Tratamento-chave
IAMCSST	Supra ≥1mm ≥2 derivações ou BRE novo	Elevada (sobe após)	ICP primária ou trombólise; dupla antiagregação
IAMSSST	Infra ST, T invertida, normal	Elevada	Heparina + dupla antiagregação; ICP por risco
Angina Instável	Infra ST ou T invertida ou normal	Normal	Heparina + dupla antiagregação; ICP eletiva

TRATAMENTO MÉDICO INICIAL — TODOS

MONA + DUPLA ANTIAGREGAÇÃO

- AAS 200-300 mg VO (dose de ataque) → 100 mg/dia indefinido
- Ticagrelor 180 mg ataque (preferido) ou Clopidogrel 300-600 mg ataque
- Heparina não-fracionada: bolus 60-70 UI/kg IV (máx 5.000 UI) + infusão; ou Enoxaparina 1 mg/kg SC 12/12h
- Nitroglicerina SL 0,4 mg: até 3x para alívio da dor (contraindicada se hipotensão, uso de IPDE-5)
- O2 apenas se SpO2 <94% (não dar de rotina — hiperóxia aumenta lesão)
- Morfina: reservar para dor intratável (pode mascarar sintomas, associada a ↑ mortalidade)
- Betabloqueador VO: nas primeiras 24h se FC>60, PA estável, sem IC/BAV (atenolol 25-50mg)

IAMCSST — REPERFUSÃO: ICP vs TROMBÓLISE

Estratégia	Indicação	Janela	Contraindicações
ICP Primária	Preferida sempre que disponível; alvo porta-balão <90 min	<12h do início da dor; até 24h se dor persistente	Ausência de laboratório de hemodinâmica
Trombólise	Quando ICP não disponível em <120 min	Até 12h; melhor se <3h	AVC hem. prev., cirurgia <3sem, HAS grave, sangramento ativo

IAMSSST — ESCORE GRACE (RISCO)

Risco GRACE	Score	Conduta
Alto	>140	ICP invasiva precoce <24h; UFH + dupla antiagregação
Intermediário	109-140	ICP em <72h; monitorar troponina seriada
Baixo	<109	Testes não invasivos; ICP eletiva se isquemia documentada
Muito alto risco	Instabilidade	ICP imediata (<2h): choque, IC, arritmia grave, dor refratária

COMPLICAÇÕES PRECOCES DO IAM

Elétricas

- FV/TV: desfibrilação imediata; amiodarona
- BAVT em IAM inferior: MP transcutâneo / transvenoso
- BAV 2ºG tipo II em IAM anterior: alto risco, MP urgente
- FA: controle de frequência + anticoagulação

Mecânicas

- Choque cardiogênico: inotrópico (dobutamina), BIA, ICP urgente
- Ruptura de parede livre: tamponamento → cirurgia emergência
- CIV pós-IAM: sopro novo + IC aguda → eco + cirurgia
- Regurgitação mitral aguda: eco + cirurgia se grave

ALTA E TRATAMENTO A LONGO PRAZO

APÓS O IAM — ALTA SEGURA

- ☐ Dupla antiagregação: AAS indefinido + Ticagrelor/Clopidogrel por 12 meses (IAM com ICP)
- ☐ Estatina de alta intensidade: atorvastatina 40-80 mg VO 1x/dia (mesmo se colesterol normal)
- ☐ IECA (ou BRA): todos com FEVE <40%, DM, HAS, DRC — iniciar nas primeiras 24h
- ☐ Betabloqueador: todos sem contraindicação (atenolol, carvedilol, metoprolol)
- ☐ Espironolactona: se FEVE ≤40% + IC ou DM, sem IRC grave
- ☐ Reabilitação cardíaca: encaminhar após alta; retornar consulta em 7-14 dias

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com dor torácica em repouso há 45 min e ECG com supradesnívelamento de ST em V1-V4. Qual conduta tem prioridade ABSOLUTA?

- A) Troponina seriada e observação por 6 horas
- B) ATC primária com alvo porta-balão <90 minutos
- C) Trombólise com tenecteplase imediatamente, sem considerar ICP
- D) Ecocardiograma para confirmar diagnóstico
- E) Nitrato IV em bomba de infusão contínua

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Em que situação a trombólise é preferida à ICP primária no IAMCSST?

- A) Paciente com AVC isquêmico há 1 mês
- B) ICP não disponível e tempo estimado porta-balão >120 min
- C) Paciente hipertenso grave com PA 200/120 mmHg
- D) Cirurgia de grande porte há 2 semanas
- E) Paciente com IAMCSST <3h e laboratório de hemodinâmica disponível

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Homem de 60 anos com IAMSSST e escore GRACE de 160. Qual é a conduta CORRETA?

- A) Alta hospitalar com AAS + estatina e retorno ambulatorial
- B) Testes de esforço na beira do leito antes de qualquer decisão
- C) ICP invasiva precoce em menos de 24 horas
- D) Trombólise com estreptoquinase
- E) Amiodarona profilática IV

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual antiagregante é PREFERIDO ao clopidogrel na SCA, por ter início de ação mais rápido e ser mais potente?

- A) Abciximabe
- B) Prasugrel
- C) Ticagrelor
- D) Dipyridamol
- E) Cilostazol

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Surgimento de sopro sistólico em borda esternal esquerda com IC aguda no 3º dia pós-IAM. Qual complicação deve ser suspeitada?

- A) Pericardite pós-IAM
- B) Ruptura de parede livre do ventrículo
- C) Comunicação interventricular (CIV) pós-IAM
- D) Dissecção aórtica
- E) Endocardite infecciosa

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

IAMCSST = emergência máxima. ICP primária com porta-balão <90 min é padrão-ouro. A trombólise fica reservada para quando ICP não está disponível em <120 min do primeiro contato médico.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A trombólise é preferida quando o tempo estimado para ICP (porta-balão) for >120 min. Contraindicações absolutas incluem: AVC hemorrágico prévio qualquer, AVC isquêmico <3 meses, cirurgia <3 semanas, HAS grave não controlada.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

GRACE >140 = alto risco → ICP invasiva precoce <24h. O escore GRACE incorpora: idade, FC, PA, creatinina, Killip, parada cardíaca, alteração ST, troponina.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Ticagrelor é preferido ao clopidogrel nas SCA: inibição mais rápida, reversível, não dependente de ativação hepática, com maior redução de mortalidade (PLATO trial). Prasugrel é alternativa. Contraindicado se AVC/AIT prévio.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Sopro sistólico novo em borda esternal esquerda + IC aguda no pós-IAM = CIV pós-IAM até prova em contrário. Confirma com ecocardiograma Doppler. Mortalidade alta sem cirurgia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico